外科学 血管和泌外疾病

核心精讲 • 泌外梗阻和外伤

（性感认识：前骑球、后骨膜）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

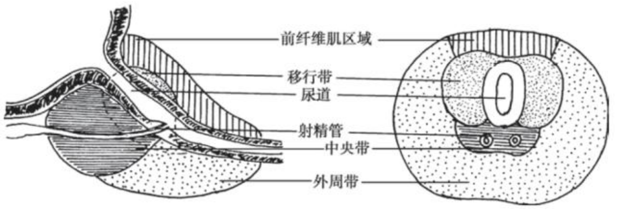
一、前列腺增生

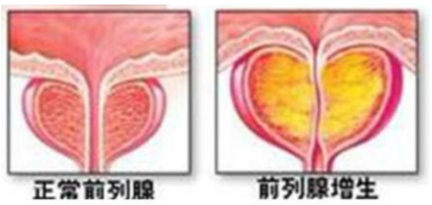
前列腺增生和前列腺癌老年人多见、与雄激素有关

①发病因素：老龄+有功能的睾丸“老男人”

②好发：**移行带**（注意：与前列腺癌无关——前列腺癌好发于外周带曾毅爱粥）

前列腺增生和前列腺癌无关,二者发病部位都不同




正常前列腺　前列腺增生

前列腺增生→发生充血→逼尿肌功能改变

①喝酒致前列腺充血②乙醇抑制ADH释放

③**尿频（最早）**，**进行性排尿困难（最典型）**，劳累、**饮酒**等加重

④**直肠指检中间沟变浅或消失（首选）**，影像学首选 B 超

前列腺增生前期是急迫性尿失禁,梗阻到一定程度后就变为充溢性尿失禁

⑤治疗：

观察随访 尿道内括约肌($\alpha 1$-R)　睾酮 $\xrightarrow{5\alpha还原酶}$ 双氢睾酮(活性最强)　膀胱逼尿肌(M-R)收缩需要钙离子,
α-R 阻断剂如特拉唑嗪、5α 还原酶抑制剂如非那雄胺。禁用 CCB 使用CCB后阻断了钙离子,不利于排尿
经尿道前列腺切除术 TURP、经尿道前列腺切开术 TUIP、经尿道前列腺剜除术 EEP（前列腺体积 80ml 以上）
并发急性尿潴留→导尿 VS 膀胱癌Tis、Ta,T1:TuRBT

肾小球肾炎也可出现　尿频　膀胱压力很高　(← →)

⑥并发症：尿潴留、急迫性尿失禁、充溢性尿失禁、膀胱结石、感染、肾后性肾功能不全、膀胱假性憩室、无痛性血尿、腹外疝、痔疮

潴留到一定程度后尿溢出　尿路梗阻　第一反应泌尿外科的恶性肿瘤

膀胱癌>上尿路癌>肾癌>前列腺癌

排尿梗阻,腹压提高

可与直疝(老男人多见)一起考

二、泌尿系结石

前列腺增生的老年男性出现直疝,若无嵌顿绞窄,先治疗前列腺增生,择期腹外疝手术,若嵌顿绞窄,先处理直疝

1.成分

草酸钙（最常见）	硬、糙、桑葚样、棕褐色（小草常见、喝了伤心） 把肾盂肾盏长满了	X 线高密度 含钙多
磷酸钙	**易碎**、糙、鹿角样、灰白色等（鹿角易掰碎） **酸化尿液+抗感染**（灵感）	X 线高密度
尿酸盐	硬、光滑、颗粒状、红色（颗颗血尿）	X 线不显影 含钙少
胱氨酸	硬、光滑、蜡样、黄色（辣黄瓜）	X 线不显影

规律:碱化尿液
特殊:磷酸盐结石酸化尿液、肝性脑病弱酸灌肠

粗糙:含钙多
光滑:含钙少或不含钙